

Rx

HAEMOSTOP

Dung dịch tiêm acid tranexamic 100 mg/mL

*Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc
Đề xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC
Thành phần hoạt chất : Acid tranexamic 100 mg/mL
Thành phần tá dược : Nước cất pha tiêm.

DẠNG BẢO CHẾ
Dung dịch trong, không màu, dùng đường tiêm tĩnh mạch chậm.

CHỈ ĐỊNH
Ngăn ngừa và điều trị xuất huyết do ly giải fibrin toàn thân hoặc cục bộ ở người lớn và trẻ em từ 1 tuổi trở lên, bao gồm :
Xuất huyết do ly giải fibrin toàn thân hoặc cục bộ :
- Rong kinh và chảy máu tử cung.
- Xuất huyết tiêu hóa.
- Tiểu ra máu.
- Phẫu thuật tai mũi họng.
- Phẫu thuật phụ khoa hoặc các rối loạn có nguồn gốc sản khoa.
- Phẫu thuật ngực, bụng và tim.
- Các biến chứng xuất huyết do điều trị tan huyết khối.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG
Cách dùng : Acid tranexamic chỉ được dùng để tiêm tĩnh mạch chậm.

Liều dùng :
Người lớn :
Xuất huyết do ly giải fibrin cục bộ : 0,5-1 g, tiêm tĩnh mạch chậm (1 mL/phút), chia làm 2-3 lần/ngày.
Xuất huyết do ly giải fibrin toàn thân : 1 g, tiêm tĩnh mạch chậm (1 mL/phút), mỗi 6-8 giờ, tương đương với 15 mg/kg thể trọng.

Bệnh nhân suy thận
Suy thận dẫn đến nguy cơ tích tụ thuốc. Acid tranexamic chống chỉ định ở bệnh nhân suy thận nặng ở bệnh nhân suy thận vừa và nhẹ được điều chỉnh dựa vào nồng độ creatinin huyết thanh:

Creatinin huyết thanh		Liều tiêm tĩnh mạch	Cách dùng
μmol/L	mg/10 mL		
120 - 249	1,35 – 2,82	10 mg/kg thể trọng	Mỗi 12 giờ
250 - 500	2,82 – 5,65	10 mg/kg thể trọng	Mỗi 24 giờ
>500	>5,65	5 mg/kg thể trọng	Mỗi 24 giờ

Bệnh nhân suy gan: Không cần điều chỉnh liều.
Trẻ em : Chỉ định của thuốc đối với trẻ em từ 1 tuổi trở lên được nêu ở mục **Chỉ định**, liều dùng khuyến cáo là 20 mg/kg/ngày. Tuy nhiên, độ liều về hiệu quả, an toàn, và liều lượng của các chỉ định này vẫn còn giới hạn.
Tinh hiệu quả, an toàn, và liều lượng của acid tranexamic đối với trẻ em phẫu thuật tim chưa được thiết lập đầy đủ. Các dữ liệu hiện tại còn hạn chế và được nêu ở mục **Đặc tính dược lý học**.
Đặc tính dược động học:
Người cao tuổi : Không cần giảm liều trừ khi có bằng chứng suy thận.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với acid tranexamic hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Có tiền sử mắc bệnh huyết khối.
Trường hợp phẫu thuật hệ thần kinh trung ương, chảy máu hệ thần kinh trung ương và chảy máu dưới màng nhện hoặc những trường hợp chảy máu não khác.
Suy thận nặng.
Tiền sử co giật.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC
Cần tuân thủ nghiêm ngặt về đường dùng thuốc : Acid tranexamic chỉ tiêm tĩnh mạch chậm, tuyệt đối không được tiêm bắp.

Co giật
Các trường hợp co giật đã được báo cáo liên quan đến điều trị với acid tranexamic.
Trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABC), hầu hết bệnh nhân được tiêm tĩnh mạch ở liều cao. Việc sử dụng acid tranexamic thấp hơn liều khuyến cáo cho thấy co giật sau phẫu thuật cũng xảy ra tương tự như ở bệnh nhân không dùng acid tranexamic.

Rối loạn thị giác
Cần chú ý rằng có thể xảy ra rối loạn thị giác, gồm giảm thị giác, nhìn mờ, thay đổi nhận thức màu, và nếu cần thiết có thể ngừng điều trị. Nếu sử dụng thuốc điều trị lâu dài, cần kiểm tra mắt định đều.

Huyết niệu
Trường hợp tiểu máu ở đường tiết niệu trên, có nguy cơ tác nhân niệu đạo.

Huyết khối
Trước khi bắt đầu điều trị với acid tranexamic, các nguy cơ về bệnh huyết khối cần được xem xét. Đối với bệnh nhân có tiền sử huyết khối hoặc bệnh nhân nguy cơ cao bệnh huyết khối, nên sử dụng acid tranexamic dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ y tế.
Nên dùng acid tranexamic thận trọng ở bệnh nhân đang dùng thuốc tránh thai đường uống vì làm tăng nguy cơ huyết khối.

Đông máu nội mạch lan tỏa (DIC)
Bệnh nhân bị đông máu nội mạch lan tỏa trong đa số trường hợp không nên điều trị với acid tranexamic. Nếu acid tranexamic được dùng thì cần theo dõi chặt chẽ bởi vì các bệnh nhân này có xu hướng hoạt hóa hệ thống ly giải fibrin, gây chảy máu nặng cấp.
Trong trường hợp phản huyết fibrin có liên quan với sự tăng đông máu trong mạch (hội chứng tiêu cục phản huyết fibrin), cần phải thiết đặt chống đông như heparin với liều cho đến đạt được cân nhắc cẩn thận. Xem xét sự cần thiết phải dùng chất kháng thrombin III cho những người bệnh có tiêu thụ những yếu tố đông máu, nếu không, sự tiêu thụ chất kháng thrombin III có thể cản trở tác dụng của heparin.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Dùng cho phụ nữ có thai
Không nên dùng acid tranexamic trong những tháng đầu thai kỳ, vì đã có thông báo về tác dụng gây quái thai trên động vật thí nghiệm. Kinh nghiệm lâm sàng về điều trị bằng acid tranexamic cho người mang thai còn rất hạn chế, cho đến nay dữ liệu thử nghiệm hoặc lâm sàng cho thấy không tăng nguy cơ khi dùng thuốc. Tài liệu về dùng acid tranexamic cho người mang thai có rất ít, do đó chỉ dùng thuốc trong thời kỳ mang thai khi được chỉ định chặt chẽ và khi không thể dùng cách điều trị khác.

Dùng cho phụ nữ đang cho con bú
Acid tranexamic bài tiết vào sữa mẹ, do đó không khuyến cáo dùng cho phụ nữ đang cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC
Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên cần chú ý rối loạn thị giác có thể xảy ra.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỲ CỦA THUỐC
Tương tác của thuốc
Không nên dùng đồng thời acid tranexamic với estrogen vì có thể gây huyết khối nhiều hơn.
Tương kỳ của thuốc:
Không cho dung dịch acid tranexamic vào dịch truyền máu hoặc dung dịch tiêm có chứa penicilin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC
Các tác dụng không mong muốn liên quan đến acid tranexamic được phân loại theo các hệ cơ quan trong cơ thể và theo thứ tự tần suất: Rất thường gặp (≥ 1/10); Thường gặp (≥ 1/100 - < 1/10); Ít gặp (≥ 1/1.000 - < 1/100); chưa biết (chưa ước lượng được tần suất).

Hệ cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Rối loạn da và mô dưới da	Ít gặp	Viêm da dị ứng
Rối loạn hệ tiêu hóa	Thường gặp	Tiêu chảy, buồn nôn, nôn
Rối loạn hệ thần kinh	Chưa biết	Có giật (đặc biệt khi lạm dụng)
Rối loạn mắt	Chưa biết	Rối loạn thị giác, kể cả thay đổi nhận thức màu
Rối loạn mạch	Chưa biết	Khó chịu kèm ha huyết áp, kèm hoặc không kèm mất ý thức (thường thấy khi tiêm tĩnh mạch quá nhanh). Huyết khối động mạch hoặc tĩnh mạch ở bất kỳ vị trí nào.
Rối loạn hệ miễn dịch	Chưa biết	Phản ứng quá mẫn, kể cả sốc phản vệ

Hướng dẫn cách xử trí tác dụng không mong muốn
Rối loạn tiêu hóa xảy ra trên 30% người bệnh, sau khi uống với liều 6 g/ngày. Các tác dụng không mong muốn do hết nếu giảm liều. Buồn nôn, chóng mặt và giảm huyết áp xảy ra sau khi tiêm tĩnh mạch nhanh.
Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu : các tác dụng không mong muốn kéo dài hoặc trở nên nặng hơn.
"Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sự hướng dẫn của dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc".

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Triệu chứng : Chưa có thông báo về trường hợp quá liều acid tranexamic. Những triệu chứng quá liều có thể là: Buồn nôn, nôn, các triệu chứng và/hoặc hạ huyết áp thể động.
Điều trị : Không có biện pháp đặc biệt để điều trị nhiễm độc acid tranexamic. Nếu nhiễm độc do dùng quá liều, gây nôn, rửa dạ dày và dùng than hoạt. Nên duy trì bổ sung dịch để điều chỉnh bài tiết thuốc qua thận và dùng các biện pháp điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỰCH HỌC
Nhóm dược lý : thuốc chống tiêu fibrin.
ATC : B02A A02.
Acid tranexamic là một dẫn chất tổng hợp của acid amin lysin có tác dụng chống tiêu fibrin, ức chế sự phân hủy fibrin trong cơ thể. Có thể tác dụng chủ yếu của acid tranexamic là ngăn cản plasminogen và plasmin gắn vào fibrin, do đó ngăn ngừa sự hòa tan của nút cầm máu; ức chế trực tiếp của plasmin khi xảy ra ở mức độ thấp. Thuốc ức chế sự giải hòa tự nhiên của fibrin, làm ổn định cục máu đông.
Nồng độ cần thiết của acid tranexamic trong huyết tương là 5-10 microgam/mL để có tác dụng ức chế tiêu fibrin. *In vitro* : Acid tranexamic tác dụng tương tự acid aminocaproic nhưng mạnh hơn gấp 10 lần, acid tranexamic ở nồng độ 1 mg/mL không làm kết tập tiểu cầu. Ở nồng độ tới 10 mg/1 mL máu cũng chưa gây ảnh hưởng đến số lượng tiểu cầu, thời gian máu đông hoặc các yếu tố đông máu trong máu toàn phần phản hoặc sau có citrat ở người bình thường. Nhưng acid tranexamic ở nồng độ 10mg và 1 mg/1 mL máu kéo dài thời gian thrombin.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC ĐỘNG HỌC
Hấp thu
Acid tranexamic đạt nồng độ cao nhất trong huyết tương sau khi tiêm tĩnh mạch khoảng 3 phút.
Phân bố
Acid tranexamic liên kết với protein huyết tương khoảng 3% ở nồng độ điều trị. Acid tranexamic không gắn với albumin huyết thanh. Thể tích phân bố ban đầu là 9-12 lít.
Acid tranexamic qua được nhau thai. Sau khi tiêm tĩnh mạch liều 10 mg/kg cho 12 phụ nữ mang thai, nồng độ acid tranexamic trong huyết tương từ 10-53 μg/mL trong khi nồng độ trong máu dây rốn là 4-31 μg/mL. Acid tranexamic khuếch tán nhanh chóng vào dịch khớp và màng khớp. Sau khi tiêm tĩnh mạch liều 10mg/kg cho 17 bệnh nhân đã qua phẫu thuật đầu gối, nồng độ thuốc trong dịch khớp tương tự với nồng độ trong huyết thanh. Nồng độ thuốc phân bố vào các mô rất thấp.
Acid tranexamic cũng được tìm thấy trong tinh dịch mà ở đó thuốc ức chế hoạt tính tiêu fibrin nhưng không ảnh hưởng đến sự di chuyển của tinh trùng.

Chuyển hóa
Thuốc được thải trừ chủ yếu trong nước tiểu ở dạng không đổi. Bài tiết qua lọc cầu thận là con đường thải trừ chính. Độ thanh thải tương đương với độ thanh thải trong huyết tương (110-116 mL/phút). Acid tranexamic bài tiết khoảng 90% trong vòng 24 giờ đầu sau khi tiêm tĩnh mạch 10 mg/kg thể trọng.
Thải trừ
Nửa đời thải trừ của acid tranexamic xấp xỉ 3 giờ.
Nồng độ thuốc trong huyết tương tăng ở bệnh nhân suy thận.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 5 ống x 5 mL.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN
Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG
24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Tiêu chuẩn có sẵn

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC
PT. Novell Pharmaceutical Laboratories
Jl. Wanaherang No. 35, Tlajung Udik , Gunung Putri, Bogor 16962, Indonesia.